

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

GDS-30 · ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE

Geriatric Depression Scale – Autoinforme de 30 ítems optimizado para la diferenciación de depresión y somatización en el anciano

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Geriatric Depression Scale (GDS - Versión de 30 ítems)
Autores Originales	Jerome A. Yesavage, T. L. Brink, T. O. Rose, O. Lum et al. (1983)
Adaptación Española	Izal y Montorio (1993); Martínez de la Iglesia et al. (2002); Bobes et al. (2004)
Tipo de Instrumento	Autoinforme estructurado o cuestionario administrado en entrevista
Población Diana	Personas mayores de 65 años en atención primaria, residencias geriátricas y psicogeriatría
Tiempo de Aplicación	8 a 12 minutos (30 reactivos de respuesta dicotómica)
Formato de Respuesta	Dicotómico: Sí / No (con 10 ítems directos y 20 invertidos)
Finalidad Clínica	Cribado diagnóstico, detección oportuna y cuantificación de la gravedad del episodio depresivo mayor en población anciana, minimizando el sesgo de quejas somáticas

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La evaluación de la depresión en personas ancianas representa uno de los desafíos psicodiagnósticos más intrincados de la medicina clínica. Las escalas clásicas de depresión (como la de Hamilton o el BDI) contienen una fuerte ponderación de síntomas somáticos y vegetativos (fatiga, enlentecimiento motor, estreñimiento, hiporexia, dolores osteomusculares e insomnio), los cuales son extremadamente prevalentes en la vejez como consecuencia del envejecimiento biológico natural y de comorbilidades médicas crónicas, generando una tasa inaceptable de falsos positivos.

Para resolver este obstáculo, Yesavage y sus colaboradores desarrollaron la GDS omitiendo deliberadamente los reactivos de quejas somáticas y centrándose de forma casi exclusiva en los aspectos afectivos y cognitivos cardinales del sufrimiento psíquico en el anciano: la pérdida de satisfacción vital, la anhedonia y abandono de intereses, el aburrimiento pertinaz, la vivencia de desamparo o inutilidad, el miedo aprensivo al futuro y los sentimientos de desesperanza y deterioro subjetivo de la memoria. Su formato dicotómico simple (Sí/No) previene la fatiga cognitiva del evaluado.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Núcleo Sintomático	Nº Ítems	Manifestaciones Clínicas Evaluadas en el Anciano
Satisfacción y Vitalidad	10 ítems	Sentirse satisfecho con la vida, con energía, con ánimo y optimismo (puntuación inversa).
Apatía y Abandono de Actividades	6 ítems	Dejar proyectos, renunciar a aficiones, preferir quedarse en casa sin hacer nada.
Desesperanza y Vacío	6 ítems	Sentir que la vida está vacía, que no hay remedio y que otros están mejor.
Quejas Subjetivas de Memoria	4 ítems	Preocupación obsesiva por fallos de atención y olvidos en la vida diaria.
Ansiedad y Desamparo	4 ítems	Miedo irracional a que pase algo malo, vivencia de indefensión e impotencia.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · GDS-30

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.89 a 0.92 en ancianos institucionalizados y no institucionalizados en España (Izal & Montorio, 1993; Martínez de la Iglesia et al., 2002).
Fiabilidad Test-Retest	Coeficiente de estabilidad temporal $r = 0.85$ tras intervalo de dos semanas en adultos mayores estables.
Validez Diagnóstica (ROC)	Con punto de corte de 10 puntos: Sensibilidad = 89%, Especificidad = 84%, AUC = 0.91 frente a criterios DSM-IV de Depresión Mayor.
Validez Concurrente	Correlación sobresaliente con la Escala de Depresión de Hamilton (HDRS, $r = 0.82$) y el Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-28, $r = 0.74$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Asignación de Puntos Dicotómicos (0 o 1):**
 - Cada respuesta que coincide con el patrón depresivo puntúa **1 punto**; la respuesta no depresiva puntúa **0 puntos**.
 - Ítems que puntúan 1 con "Sí" (20 ítems):** 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28.
 - Ítems que puntúan 1 con "No" (10 ítems de bienestar):** 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29, 30.
- Puntuación Total:** Suma de las respuestas afirmativas directas más las respuestas negativas de los ítems de bienestar.
- Rango de Puntuación:** De 0 a 30 puntos.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación GDS	Estratificación	Probabilidad Depresión	Directriz Asistencial Recomendada
0 a 9 puntos	Normal / No Depresión	Baja (< 10%)	Patrón anímico adaptativo normal. Seguimiento de rutina.
10 a 13 puntos	Depresión Leve / Sospecha	Intermedia (Corte 10)	Cribado positivo. Requiere valoración clínica estructurada.
14 a 19 puntos	Depresión Moderada	Alta (> 80%)	Depresión mayor manifiesta; iniciar tratamiento activo.
20 a 30 puntos	Depresión Severa	Muy Alta (> 95%)	Cuadro severo con riesgo vital/cognitivo; derivación preferente.

PUNTO DE CORTE OFICIAL (GDS-30 ≥ 10): El umbral de 10 puntos en la GDS de 30 ítems es el punto de corte estándar validado en la práctica psicogeriátrica española. Posee una sensibilidad del 89% y especificidad del 84%. En pacientes muy añosos o con deterioro cognitivo leve se utiliza a menudo un corte más específico de 11 o 14 puntos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · GDS-30

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Cribado Geriátrico Anual: Administrar en revisiones de crónicos o ante quejas de memoria y abandono del autocuidado.

Paso 2: Conducta Asistencial:

- **Si GDS < 10:** Descartar depresión mayor. Promover actividades de estimulación física y social.
- **Si GDS ≥ 10:**
 1. Realizar despistaje cognitivo con el Miniexamen Cognoscitivo (MEC / MMSE) para descartar pseudodemencia depresiva.
 2. Solicitar analítica básica geriátrica: TSH, vitamina B12, ácido fólico, hemograma y función renal.
 3. Iniciar abordaje farmacológico con antidepresivos de bajo perfil anticolinérgico y cardiovascular (ISRS como sertralina o escitalopram, o mirtazapina si coexiste insomnio pertinaz y pérdida de peso).
 4. Activar recursos de apoyo domiciliario o centros de día para romper el aislamiento.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 76 años, viuda desde hace un año, traída a la consulta de atención primaria por su hija por quejas continuas de “estar perdiendo la cabeza”, despistes en la compra y abandono de sus paseos habituales.

Evaluación Psicométrica Inicial: GDS-30 = 21 / 30 puntos (Depresión Geriátrica Severa).

- Responde “No” a estar satisfecha con su vida (ítem 1) y a sentir energía (ítem 21).
- Admite que siente su vida vacía (ítem 3 = Sí), que se aburre a menudo (ítem 4 = Sí), que prefiere quedarse encerrada en casa (ítem 10 = Sí) y que teme que ocurra una desgracia (ítem 6 = Sí).
- MMSE = 26 / 30 (Déficit de concentración atencional sin apraxias ni afasias estructurales).

Manejo y Evolución: La GDS-30 confirmó que las quejas subjetivas de memoria eran la expresión de una pseudodemencia depresiva mayor en el contexto del duelo complicado y el aislamiento sobrevenido. Se inició tratamiento con sertralina 50 mg/día asociada a vinculación a un taller de estimulación cognitiva y manualidades en el centro social de mayores. En la reevaluación a las 12 semanas, la GDS descendió a 6 puntos, recuperando la paciente su autonomía y remitiendo por completo los fallos atencionales.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Los ancianos tienen la tasa de suicidio consumado más alta por rango de edad; no minimizar ideas de pasividad (“ya estorbo aquí”).
- Evitar tricíclicos potentes en ancianos por riesgo de caídas, hipotensión ortostática, retención urinaria y arritmias cardíacas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Enfermedad de Alzheimer Incipiente:** Pérdida de memoria insidiosa con anosognosia y sin la angustia afectiva que exhibe el deprimido.
- **Hipotiroidismo o Déficit de B12:** Causas médicas reversibles de letargia, astenia y bradipsiquia en la vejez.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Yesavage, J. A., Brink, T. L., Rose, T. L., Lum, O., Huang, V., Adey, M., & Leirer, V. O. (1983). Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. *Journal of Psychiatric Research*, 17(1), 37–49.
- Izal, M., & Montorio, I. (1993). Adaptación de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage en población española. *Revista de Gerontología*, 3(4), 214–223.
- Martínez de la Iglesia, J., Onís Vilches, M. C., Dueñas Herrero, R., Albert Colomer, C., Aguado Taberné, C., & Luque Luque, R. (2002). Versión española del cuestionario de Yesavage abreviado (GDS) para el despistaje de depresión en mayores de 65 años: Adaptación y validación. *Medifam*, 12(10), 620–630.
- Brink, T. L., Yesavage, J. A., Lum, O., Heersema, P. H., Adey, M., & Rose, T. L. (1982). Screening tests for geriatric depression. *Clinical Gerontologist*, 1(1), 37–43.